

מדיניות המרכז הרפואי הדסה פרוטוקול – שמירה וטיפול בעור פגים ויילודים בטיפול נמרץ מספר: 02-02-05-53			
הספר: 02 - שרותי רפואה		התחום: 02 – מחלקות אשפוז	
הנושא: 05 – ילדים ויילודים		הפרוטוקול: 53 - שמירה וטיפול בעור פגים ויילודים בטיפול נמרץ	
מהדורה: ראשונה		פרסום: ספטמבר 2025	עמוד 1 מתוך 15
הנוהל נכתב ע"י: דפנה חיוורוני טיפול נמרץ פגים ה"צ.			
הנוהל אושר ע"י: פרופ' סמדר אבן טוב פרידמן מנהלת אגף נאונטולוגיה, ד"ר נעה אופק מנהלת מחלקת פגים וילודים ע"כ, פרופ' זיוונית ארגז-שאלתיאל מנהלת יחידת פגים וילודים ה"צ (לשעבר), טליה לב אחות ראשית פגיה ע"כ, טליה ויזנר אחות ראשית פגיה ה"צ.			
גורם מתאם בבית החולים: ציפי עזריה שיפמן מנהלת תחום נהלים וסטנדרטים מקצועיים, המערך לאיכות ובטיחות.			
תחומי האקרדיטציה: COP 3 (מהדורה JCI 7)			
הנוהל מיועד לנשים ולגברים כאחד			

1. מבוא

- 1.1. פג וילוד בלידתם עוזבים את הסביבה הלחה, החמה והסטרילית ברחם ומגיעים לסביבה קרה, יבשה ולא סטרילית.
- 1.2. לעור תפקידים רבים כגון: ויסות חום הגוף, מניעת התייבשות של רקמות ע"י בידוד הנוזל החוץ-תאי, מאגר לחומרי מזון, שומן, מים, מלחים, בנוסף העור מהווה הגנה על רקמות שמתחתיו מפני פגיעה מכנית, העור הוא איבר תחושה חשוב ומכיל קולטנים לאבחון תחושת חום, קור, מגע עדין, לחץ וכאב, בנוסף העור הוא חלק ממערכת החיסון ומהווה את המחסום הראשוני בפני פתוגנים וכימיקלים.
- 1.3. **שכבות העור הן:**
 - 1.3.1. אפידרמיס: שכבת המגינה מפגיעות חיצוניות.
 - 1.3.2. דרמיס: שכבה המכילה קולגן וסיבים אלסטיים ומאפשרת גמישות ושינויי צורה, מכילה מס' רב של כלי דם ועצבים.
 - 1.3.3. שכבת השומן התת עורי: מהווה חומת מגן לאברים הפנימיים ומחסן קלוריות.
 - 1.3.4. משבוע 28 המבנה הבסיסי של העור זהה לפג יילוד ובוגר, ההבדל הוא פחות חומר, ולכן פחות תפקוד.
- 1.4. ככל שהגיל צעיר יותר כך שכבות העור דקיקות יותר.
- 1.5. שכבת האפידרמיס של הפג מבשילה מהירות לאחר הלידה ותוך שבועיים עד שלושה מהלידה דומה במבנה שלה לזו של תינוק בשל.
- 1.6. העור הלא בשל הוא דק ולכן פגיע, מכיוון ששכבות העור דקיקות וסיבי החיבור מועטים יש סכנה גדולה יותר לפגיעה בעור.
- 1.7. העור סופג חומרים שונים ותרופות במהירות ולכן קיימת סכנה גדולה באיבוד נוזלים. מכיוון שהיחס בין השטח לגוף הוא גדול ככל שמשקל הפג נמוך יותר הסכנה גדולה בהתאם.
- 1.8. מניעת פגיעה בעור וטיפול מידי ומיטבי במקרה של פגיעה בעור פגים ויילודים הכרחית למניעת סבל, כאב, זיהומים, אשפוזים ארוכים, צלקות ואף מוות.
- 1.9. ככל שהיילוד צעיר יותר ומצבו הקליני מורכב ולא יציב, הוא נמצא בסכנה גדולה יותר לפגיעה בעור עקב: חוסר בשלות של שכבות העור, ועוביין הדק, איבוד חום.
- 1.10. איבוד לחות, חוסר תנועתיות, שימוש במגוון אביזרים ותהליכים הפוגעים בשלמות העור – דקירות, עירויים, בדיקות, הדבקת מדבקות שונות והסרתם, הדבקת טובוס, פרפוזיה ירודה, חוסר איזון של אלקטרוליטים, חוסר אספקה של תזונה מאוזנת ועשירה לגוף.



2. מטרה

- 2.1. לקדם טיפול מיטבי בעור היילודים בטיפול נמרץ פגים על ידי שמירה, על שלמות העור, מניעת והקטנת פגיעה בעור, ביצוע הערכה וטיפול בפגיעות עור הכוללות כוויות כימיות, פצעי לחץ, קרעים ושפשופים, ופגיעות שנגרמו מאקסטרוזציות של נוזלים המוזלפים לכלי דם (פרה).
- 2.2. לקדם מניעת כאב ביילודים.
- 2.3. להטמיע מניעת פגיעות בעור וטיפול בפגיעות במידת הצורך כשגרת טיפול בפגייה.

3. חלות

- 3.1. אחיות המטפלות בפגים וילודים אשר מאושפזים ביחידה לטיפול נמרץ בפג ובילוד וביחידת הביניים.

4. סמכות ואחריות

- 4.1. הסמכות להערכת מצב העור וטיפול בו לפי הצורך, מוטלת על האחות המטפלת, בכפוף לקריטריונים שהוגדרו בנוהל זה.
- 4.2. באחריות האחות המטפלת לתעד את אומדן העור, הפגיעה והטיפול ניתן וכן לצלם את אזור הפגיעה בכל יום כדי לעקוב על התקדמות הטיפול הניתן.
- 4.3. באחריות האחות המטפלת לעדכן את הרופא המטפל ולערבו בטיפול במידת הצורך.
- 4.4. באחריות האחות המטפלת לעדכן את ההורים במצב העור, להדריך אותם כיצד למנוע פגיעות עור וכיצד לטפל במידת הצורך.
- 4.5. באחריות האחות להפסיק את הטיפול בהתאם למצב הילוד.

5. הגדרות

- 5.1. פג – תינוק שנולד בלידה מוקדמת לפני שבוע 37 להריון.
- 5.2. עור – מעטפת חיצונית, המכסה כמעט את כל גוף האדם ומהווה 15% ממשקלן. העור הינו האיבר הגדול והרחב ביותר בגוף.
- 5.3. פצע – פגיעה בשלמות העור
- 5.4. פצע לחץ – פגיעה בשלמות העור כתוצאה מהפעלת כוח ממושכת על אותו שטח עור. גורמים שונים מעלים את הסיכון להתפתחות פצע לחץ – גורמים פנימיים כגון מצב המטופל וגורמים חיצוניים כמו כוחות המופעלים על העור.
- 5.5. קרע / שפשוף – פגיעות בשלמות העור כתוצאה מחתך או תנועה חוזרת ונשנית.

6. אוכלוסיית יעד

- 6.1.1. פגים ויילודים המאושפזים ביחידה לטיפול נמרץ בילוד וביחידת הביניים.
- 6.1.2. הורים לילודים ופגים המאושפזים בטיפול נמרץ בילוד.

7. התוויות

- 7.1.1. יש לבצע אומדן מצב העור לכל יילוד המאושפז בפגייה (ללא קשר לגילו ומשקלו).



8. התוויות נגד

8.1.1. תינוקות המוגדרים כ-MINIMAL HENDLING ו/או "שומרי ראש" ב-72 השעות הראשונות לחייהם: יש לעשות אומדן רק בחלקים הנראים לעין ללא תזוזה.

9. שיטה

9.1. עקרונות:

- 9.1.1. ביצוע הערכה מקיפה לסיכון בפגיעה בעור וזיהוי כל גורמי הסיכון כדי לנסות למנוע ולמזער פגיעה בעור ולמנוע סיבוכים אפשריים הנובעים מפגיעה בעור.
- 9.1.2. גישה הכוללת עבודה על פי סטנדרטים מובנים, כלי הערכה המוכרים לצוות, מגוון גישות למניעת פצעים וחינוך הצוות והמשפחות לערנות והבנת הגורמים המביאים לנזק בעור.
- 9.1.3. הקפדה ותיעוד של אומדן העור, ובמידה וקיימת פגיעה בעור תיאור הפגיעה והטיפול הניתן.
- 9.1.4. הכשרת כל הצוות הסיעודי במחלקה לבצע הערכה של מצב העור ופגיעות בו
- 9.1.5. הכשרת וצוות נאמנות טיפול בעור שמתפקידן יהיה לעדכן את הצוות מעת לעת בדבר חידושים ומידע סיעודי ורפואי הנוגעים לנושא.
- 9.1.6. נקיטת פעולות מניעה והגנה על העור תוך תזכורת מתמדת – כי מניעה עדיפה על טיפול בכל עת.

9.2. הנחיות בסיסיות:

- 9.2.1. אין להוריד VERNIX שלא לצורך.
- 9.2.2. יש לטפל בכל התינוקות בעדינות.
- 9.2.3. יש לקחת בחשבון את הייחודיות של כל יילוד ולבצע הערכה בהתאם למצבו.
- 9.2.4. לניקוי העור יש להשתמש במים וסבון "ללא סבון" עם PH מאוזן.
- 9.2.5. יש ליבש את העור בעדינות על ידי טפיחות ולא בשפשוף.
- 9.2.6. ניתן ללחלח את העור עם שמן חמניות או קרם לחות, ללא חומרים משמרים וללא פרבנים.
- 9.2.7. יש להחליף חיתול עם שתן / צואה כל 3 שעות ולהשאיר את אזור הישבן נקי ויבש.

9.3. גישה עקרונית לטיפול בפצעים:

- 9.3.1. שמירה על לחות באזור הפצע.
- 9.3.2. טיפול ברקמה פגועה ומתן מענה לזיהום.
- 9.3.3. מניעת סיבוכים.
- 9.3.4. טיפול בפצע עד לריפוי מלא.

9.4. אומדן:

- 9.4.1. האומדן הראשון של העור יבוצע לא יותר משעתיים מקבלת היילוד למחלקה, תוך שימוש בסרגל שפותח במחלקה המבוסס על סרגל NSCS ([נספח 1](#))
- 9.4.2. יש לבצע אומדן עור כל 8 שעות לפחות או על פי הנדרש על פי הניקוד שניתן במהלך האומדן ועל פי גורמי הסיכון, יש לתעד את הציון שניתן באומדן בדיווח היומי.
- 9.4.3. במידה ויש פגיעה בעור יש לתעד אותה על פי מפת אומדן פצע ([נספח 4](#)).
- 9.4.4. אומדן העור יכלול התייחסות מעמיקה לנושאים הבאים:
 - 9.4.4.1. שינויים ברמת הלחות בעור (סדקים, אזורי קילוף בצקות)
 - 9.4.4.2. טורגור של העור
 - 9.4.4.3. טמפרטורת העור והאם יש הבדלים בין אזורים שונים
 - 9.4.4.4. ממצאים חריגים, פצעים ופגיעה בעור (פריחה, אודם, שלפוחיות, המנגיומות)



- 9.4.4.5. פרפוזיה
- 9.4.4.6. שיינויים בצבע העור (עור שיש, אודם)
- 9.4.4.7. אומדן כאב
- 9.4.4.8. כל פגיעה בעור כתוצאה מלחץ של מיכשור
- 9.4.4.9. כל פגיעה בעור כתוצאה מפרוצדורות והתערבות ניתוחית
- 9.4.4.10. התייחסות למצב הטבור בכל החתלה (לחפש דלקות, הפרשות ודימום)
- 9.4.4.11. אומדן אזור עירוניים (פריפריים ומרכזיים)
- 9.4.4.12. מצב עור הישבן בכל החתלה

9.4.5. את אומדן העור יש לבצע תוך כדי בדיקת כל גוף התינוק והתרכזות באזורים הנמצאים בסכנת יתר

כגון:

- 9.4.5.1. אוזניים: סכנת פרפוזיה ירודה – כאשר תינוק שוכב על אחד מצדי הראש נגרם לחץ על האוזניים שעלול לגרום לפרפוזיה ירודה (מניעה: יש לבצע שינויי תנוחה, לוודא שמשקפי החמצן לא לוחצים על האוזניים), יש לבצע אומדן הבדוק גם מה נמצא מתחת למשקפיים.
- 9.4.5.2. אף וספטום: אזור רך, שמופעל עליו לחץ עם אביזרים כמו משקפי חמצן, קנולת וואפטרם וכו' (מניעה: ריפוד אזור הספטום בחבישות קצף / NEOSEAL).
- 9.4.5.3. לחיים: הדבקות מרובות של פלסטרים (מתחת לזונדה, מתחת למחזיק טובוס, מתחת למשקפי חמצן) (מניעה: מריחת שכבת מגן סיליקונית כמו cavilon מתחת לפלסטרים והסרה עם מסיר דבק).
- 9.4.5.4. כפות ידיים ורגלים: סכנת פגיעות עקב לחץ וכוויות ממד סטורציה, חיטוי בזמן הכנסת עירוניים, דליפה מעירוניים, לחץ עקב סחיטת עקב. (מניעה: צמצום דקירות במידת האפשר).
- 9.4.5.5. ראש / קרקפת: סכנה לפצעי לחץ עקב כובד וחוסר תנועתיות.
- 9.4.5.6. גב: סכנה לפצעי לחץ עקב אי שינוי תנוחה בימים ראשונים (minimal handling) או עקב פרוצדורות ניתוחיות.
- 9.4.5.7. ישבן: עקב רטיבות והפרשות – סכנה לתפרחת חיתולים ועד פצעים מדממים.
- 9.4.5.8. טבור: סכנה לזיהומים עקב הפרשות ועקב החדרת צנתרים מרכזיים.

9.5. סדר פעולות ביצוע אומדן עור:

- 9.5.1. יש לבצע אומדן מובנה: מראש התינוק כלפי מטה, גפיים, גב וישבן.
- 9.5.2. במהלך האומדן יש לסובב בעדינות את ראש היילוד ימינה ושמאלה, בדיקת אפרכסת האוזן ומאחורי האוזן, בדיקת הקרקפת, אזור הלחיים והסנטר.
- 9.5.3. במידה והתינוק מונשם יש לבדוק את אזור החניכיים והלוע (מחלקות המנשימות דרך האף – בדיקת אזור מערת האף והספטום).
- 9.5.4. במידה והתינוק מקבל תמיכה נשימתית כמו: משקפי חמצן / HIGH FLOW / RAM CANULA יש לבדוק את הספטום, הנחיריים ומחיצת האף.
- 9.5.5. יש להטות את הראש ולבדוק את אזור הצוואר.
- 9.5.6. במידה ולתינוק יש טרכאוסטומי יש לבדוק את אזור כניסת הקנולה ואזור הצוואר (קדימה ואחורה).
- 9.5.7. יש לבדוק גפיים וכפות ידיים ורגליים.
- 9.5.8. תינוק עם עירוי, יש לבדוק את אזור העירוי כל 3 שעות ולהוציאו מיד עם גילוי של אודם / הלבנת האזור / רגישות / נפיחות / חום מקומי וכדומה.



9.5.9. תינוק עם עירוי המכיל Ca, TPN – יש להקפיד באופן מיוחד על בדיקת העירוי.

9.5.10. תינוק, שעקב מצבו, יש לקחת מהעקב דגימות דם מרובות, יש לאמוד את אזור העקבים ולשקול דרך אחרת ללקיחת דגימות הדם.

9.5.11. תינוק בעל צנתר עורקי - פריפרי, יש להקפיד על בדיקת האצבעות בסוף הגפה עם הצנתר.

9.5.12. יש להשוות בין 2 הגפיים ולשלול נפיחות / אודם / חום מקומי.

9.6. גורמי סיכון המעלים סיכוי לפגיעה בעור:

9.6.1. לידה ב שבוע 32 ומטה

9.6.2. פגיעה ווסקולרית או פרפוזיה ירודה (אנצפלופטיה, אינוטרופים, קירור), פגיעה נירולוגית / פירכוסים

9.6.3. חוסר תזוזה עקב סדציה / שיתוק / תחלואה

9.6.4. זיהום / התייבשות / בצקת קשה

9.6.5. הנשמה לסוגיה כולל דרך צינור תוך קני, או הנשמה נזלית דרך CPAP/ NIPPV / HHNC= VAPOTERM / משקפי חמצן

9.6.6. ניתוח בשבוע אחרון

9.6.7. נקז חזה

9.6.8. צנתר מרכזי UA / UV // PICC / CL

9.6.9. עירוי פריפרי

9.6.10. GASTROSTOMY / ILEOSTOMY / סטומה

9.6.11. TRACHEOSTOMY

9.6.12. מחלות עור

9.6.13. Minimal Handling

9.6.14. ריור / פליטות

9.6.15. הזעה

9.6.16. דליפה מצנתרים

9.6.17. צום (NPO)

9.6.18. הזנה אנטרלית (TPN)

9.6.19. ציוד לניטור כולל כבלים ולידים

9.6.20. פלסטרים וקיבועים שונים

9.7. סוגי הפצעים שניתן למצוא בפגים ויילודים:

9.7.1. כוויות

9.7.2. אקסטאווציה / EXTRAVASATION

9.7.3. שפשופים

9.7.4. קריעת עור

9.7.5. פצעי לחץ

9.7.6. דרמטיטיס

9.7.7. תפרחת חיתולים

9.7.8. פצעים כירורגיים

9.7.9. זיהומים

9.8. מניעה והגנה על העור:

9.8.1. יש למרוח בכל גיל ובכל שבוע חומר המגן על העור מתחת לכל פלסטר, מדבקה, קיבוע וכו'.



9.8.2. מומלץ להשתמש בחומר כמו CAVILON שמורכב מ-100% סיליקון (בספוגית או מטוש), הוא יוצר שכבת הגנה על העור מפני גירויים כמו: נזלים והפרשות ומגן מפני חיכוך, שפשוף או לחץ הנגרמים מחבישות, מכשור וכדומה. חומרים זה ומר הוא שקוף, נושם והיפו אלרגני, כמו כן אינו רעיל ואינו מכיל אלכוהול.

9.9. פלסטרים / דבק / הסרת פלסטרים:

- 9.9.1. יש לבחור בפלסטרים שממזערים טראומה לעור. אין להשתמש בפלסטר "שקוף" על עור פגים ותינוקות (MICROPOR).
- 9.9.2. מתחת לכל הדבקה יש למרוח שכבת מגן סיליקונית כדי להגן על העור.
- 9.9.3. בנקודות לחץ ושפשוף יש להוסיף מגיני עור. לדוגמא: שימוש ב-NEOSEAL כהגנה על הספטום.
- 9.9.4. רצוי להימנע מהורדת דבק ב-24 שעות לאחר ההדבקה.
- 9.9.5. יש להסיר דבק / פלסטרים עם מסירי דבק, יש להסיר בסבלנות ועדינות ולא לגרום לקרע בעור התינוק.
- 9.9.6. להסרת פלסטרים רחבים כגון טגדרם, רצוי להשתמש בספריי על בסיס סיליקון, ללא אלכוהול.
- 9.9.7. יש להשתמש באלקטרודות א.ק.ג על בסיס הידרוג'ל.

9.10. אומדן ודיווח:

- 9.10.1. במידה ובמהלך אומדן העור נתגלתה פגיעה / פציעה בעור או שעקב מהלך ידוע (ניתוח) יש פגיעה בעור, יש לבצע הערכה של הפגיעה לפי סרגל אומדן פצע ולסמן בדף דיווח על פגיעה בעור ([נספח 3](#)).
- 9.10.2. יש לצלם את הפצעים, לשלוח ל"נאמנות פצע" ולעקוב בעזרת צילומים חוזרים (יש לצלם בתדירות המתאימה למצב הפצע לעיתים אף אחת ל-24 שעות) על החמרה או שיפור.
- 9.10.3. יש לדווח על פגיעות חמורות בעור לרופא אחראי.
- 9.10.4. יש לבנות ולתעד תוכנית טיפול לפצע בהתאם להמלצות סרגל פצע תוך התייעצות עם "נאמנות פצעים" מחלקתיות ובמידת הצורך - אחות פצעים מוסדית.
- 9.10.5. יש לבצע הערכה חוזרת של העור והפצעים בתדירות מתאימה, לפי ההמלצות המתקבלות בסרגל אומדן עור.
- 9.10.6. יש להקפיד על אומדן כאב ומתן נוגדי כאבים לפי הצורך.

9.11. טיפול בפצע:

- 9.11.1. יש להיעזר בטבלה המצורפת כדי להתאים את הטיפול לפצע.
- 9.11.2. טיפול בדבש רפואי:
- 9.11.2.1. טיפול הבחירה בפצעים הוא חבישות / ג'ל המכיל דבש (עדיפות לדבש רפואי מפרחי המנוקה).
- 9.11.2.2. המרכיב הפעיל בדבש מנוקה הוא מתיל גליוקסאל (MGO).
- 9.11.2.3. מרכיב זה הוא האחראי על פעילותו האנטי בקטריאלית, ואינו קיים בסוגי דבש אחרים.
- 9.11.2.4. הריכוז שלו בדבש מנוקה הוא בין 38 ל-761 מ"ג לק"ג.
- 9.11.2.5. הדרישה המינימלית לפעילות אנטיבקטריאלית היא 100 מ"ג לק"ג.
- 9.11.2.6. נמצא כי ככל שריכוז החומר הפעיל גבוה יותר, הפעילות האנטיבקטריאלית חזקה יותר.
- 9.11.2.7. הודות לצמיגות הדבש כשהוא נמצא על פצעים פתוחים הוא מהווה שכבת מגן בין הפצע והסביבה המזהמת, מונע חדירת חיידקים שומר על סביבה לחה, מעודד בניית רקמה חדשה אחידה, יוצר גלד אחיד ומונע צלקות.



- 9.11.2.8. הדבש מעודד צמיחת נימי דם ומזרז על ידי כך התפתחות של תאים חדשים והחלמה.
- 9.11.2.9. הדבש אינו נצמד לרקמה ואין סכנה לניתוקה ממקום הטיפול בזמן החלפת חבישה.
- 9.11.2.10. הסוכרים בדבש סופחים את נוזלי הלימפה וכך למעשה מנקים את אזור הפצע.

10. הכשרה והטמעה

- 10.1. הנוהל יופץ לעובדים באופן ישיר למייל האישי שלהם בהדסה ועל-ידי המנהלים הישירים.
- 10.2. הדרכה בנוגע לנוהל זה תינתן בעת קבלת עובד חדש למחלקה.
- 10.3. באחריותם של מנהלי המחלקות והאחיות הראשיות להטמיע נוהל זה בקרב העובדים שלהם.

11. סימוכין

- 11.1. משרד הבריאות חוזר מנהל הסיעוד, בנושא: [מניעה וטיפול בפצעי לחץ, מספר: 66/2006](#)
- 11.2. משרד הבריאות: חוזר מנהל הסיעוד, בנושא: [החלטה על טיפול בחבישות ומשחות בפצעי לחץ מדרגה ראשונה ושנייה, מספר: 126/2017](#)
- 11.3. בית החולים הדסה: נהלי המוסד, בנושא: [נוהל מניעה וטיפול בפצעי לחץ, מספר: 03-05-01-01](#)
- 11.4. [Dressings and Products in Pediatric Wound Care, ADVANCES IN WOUND CARE, VOLUME 3, NUMBER 4 Copy 2014 by Mary Ann Liebert, Inc.](#)
- 11.5. [NEONATAL SKIN ASSESSMENT AND INJURY PREVENTION-guideline 18/4/2018 Alberta Health services.](#)
- 11.6. [Kusari, A., Han, A. M., Virgen, C. A., Matiz, C., Rasmussen, M., Friedlander, S. F., & Eichenfield, D. Z. \(2019\). Evidence-based skin care in preterm infants. Pediatric dermatology, 36\(1\), 16-23](#)
- 11.7. [Pressure injuries in Neonates, A Literature Review, Durk van der kuip, Annika Opperbeek Bachelor's thesis October 2016](#)
- 11.8. [Developing an Australian skin risk assessment and management tool for neonates, Broom MM, Burton WA, Ehrlich LM, Dunk AM & Abdel-Latif ME, Volume 25 Number 1 – March 2017](#)

12. נספחים

- 12.1. [נספח 1](#): סרגל אומדן עור
- 12.2. [נספח 2](#): הנחיות לרחצת פגים
- 12.3. [נספח 3](#): דף דיווח על פגיעה בעור
- 12.4. [נספח 4](#): הנחיות לטיפול בפגיעה בעור
- 12.5. [נספח 5](#): סרגל BRANDEN Q



נספח 1: סרגל אומדן עור

אומדן עור לפגים על פי - NSCS + BRANDEN Q									
ניקוד	יובש			אודם			פגיעה בשלמות העור		
	אין עדות ליובש בעור	עור יבש מעט קשקשת	עור מאד יבש, נשבר, פיסורה - fissures	אין עדות לאודם	נראה אודם מקומי	נראה אודם מפושט	אין עדות לפגיעה	מעט, ממוקם, אזורית	פגיעה נרחבת
חלק א	1	2	3	1	2	3	1	2	3
חלק ב	תוספת ניקוד: מתחת שבוע 32 (1) הנשמה לסוגיה- כולל NIPPV/CPAP (1) פגיעה ווסקולרית/ניתוח/זיהום (1) Minimal Handling (1) שיתוק (1)								
חלק ג	תוספת ניקוד: ציוד/חפצים/משטח קשה לוחץ וניתן להקלה (1) ציוד/חפצים/משטח קשה היוצר לחץ ממושך שלא ניתן להקלה (2)								
סה"כ	3			4-8			8-15		
	לא נמצא בסכנה			נמצא בסכנה			סכנה גדולה		
	להמשיך במעקב שגרתי, השתמש באמצעים שונים למניעת פגיעה בעור ולעקוב אחר שינויים			יש להגביר את המעקב לכל 4 שעות, לשנות תנוחה כל 2-3 ולהפחית לחץ על מקום הפגיעה, להמשיך באמצעים שגרתיים למניעת פצעים			אם המצב מאפשר, יש לבדוק את העור כל שעה, אם המצב מאפשר, יש לעשות שינוי תנוחה בתדירות גבוהה. לוודא שאין ציוד שלוחץ על העור. אם המצב מאפשר – יש לשנות מיקום ציוד כל שעותיים. לשקול שימוש בחומרים וציוד מיוחד למניעת פצעים ומניעת לחץ על העור.		

**נספח 2 הנחיות לרחצת פגים****אוכלוסיית יעד:**

ילודים/ פגים המאושפזים ביחידת טיפול נמרץ פגים ובמחלקת ביניים בפגיה.

מדיניות

- **רחצת פגים** וילודים תבוצע עד פעמיים בשבוע עפ"י ההנחיות בנוהל זה
- העקרונות העומדים בבסיס הנוהל מבוססים על עקרונות טיפול התפתחותי תומך, שמירה על שלמות העור ומניעת זיהומים

רחצת פגים

רמת ה-PH אצל יילוד במועד זהה לאדם בוגר החל מגיל 4 ימים ואצל הפג החל מגיל כשלושה שבועות. לכן בתקופה זו, תכיפות הרחצה וחומרי הרחצה משפיעים על רמת ה-PH ומעלים את הסיכון לזיהום. כמו כן שימוש בסבון או תחליב רחצה עלולים לגרום לגירוי העור ולשינוי של רמת ה-PH.

הסרת הוורניקס פוגעת בהגנה החיסונית של העור.

ה- "VERNIX" היא שכבה שומנית לבנה המכסה את עור התינוק. השכבה מגינה על עור התינוק ומבודדת אותו מהסביבה ומגינה מפני חיידקים.

ה- VERNIX מעודד הבשלה של העור, מגן מפני פציעות, זיהומים ומונע איבוד מים דרך העור.

הנחיות כלליות לרחצת פג/ ילוד:

- רחצה ראשונה תלויה בשבוע לידה ובגיל הילוד/פג ותבצע בהתאם לטבלה המצורפת
- פגים שנולדו לפני שבוע 29 שלהריון ירחצו רק לאחר 10 ימים, בתוך האינקובאטור, פגים מתחת לשבוע 28 ניתן לנקות בעדינות עם שמן חמניות בשכבה דקה
- האחות תפעיל שיקול דעת בהחלטה לגבי הרחצה הראשונה, בהתאם למצבו הרפואי של הפג/ ילוד (ראה התוויות נגד יחסיות)
- במידה והפג/ילוד זקוק לניקוי יסודי לאחר הלידה, עקב הפרשות ולכלוך מרובים כגון- מקונוים, דם וכו', האחות תסיר גושי לכלוך ותנגב את עור הפג / ילוד בהתאם לשיקול דעתה
- תכיפות רחצת הפג/ילוד היציב תבוצע **כל 4 ימים**
- יש להשתמש בקערת רחצה סטרילית לפגים המאושפזים באינקובאטור
- יש להכין את כל הצידוד הנדרש לרחצה מראש
- בעת הרחצה, רצוי שטמפרטורת החדר תהיה בין 24-25°. טמפרטורת המים באמבט צריכה להיות חמימה; 37-38°. יש לבדוק את טמפרטורת המים ע"י מדחום.
- תכשיר רחצה המתאים לשימוש בפג, הינו אל סבון בעל **PH** ניטרלי. יש להכין מראש אל סבון בתוך כוס חד פעמית לשימוש אישי לרחצה
- בילודים בשבוע 32 ומעלה ניתן להוסיף סבון תינוקות עם PH בסיסי, ובמידה והעור יבש, ניתן להוסיף שמן חמניות למים. (חמניות / זית / אמול) או להשתמש בסבון מתאים. לדוגמא: סבון שיבולת שועל



- לפני הרחצה, יש לחטא ידיים ולעטות כפפות
- הרחצה תתחיל מאזור הראש כלפי מטה, מאזור נקי לאזור מלוכלך
- יש להקפיד על רחצה בין קפלי העור, כגון צוואר, בתי שחי ומפשעות, אין לשפשף את העור.
- משך הרחצה לא יעלה על 8 דקות
- בסיום הרחצה יש להסיר את הכפפות ולחטא ידיים
- הורים המעוניינים להיות נוכחים בעת הרחצה יוכלו להישאר בזמן זה לצד ילדם וללמוד כיצד לסייע בפעולת הרחצה.
- בתינוקות יציבים, ביחידת הביניים, אשר הוריהם עברו הדרכה לרחצה וזו תועדה בתיק המטופל, ההורים יוכלו לרחוץ את ילדיהם באופן עצמאי לאחר שקיבלו את אישור האחות המרכזת טיפול, זאת תחת השגחה ובפיקוח הצוות הסיעודי בלבד

רחצה באינקובאטור:

- פגים/ ילודים השוהים באינקובאטור ושמשקלם פחות מ-1500 גרם יעברו רחצה באינקובאטור
- פגים/ ילודים שנולדו לפני שבוע 29 להריון ירחצו רק לאחר היממה העשירית לחייהם. לצורך הרחצה יש להשתמש בבקבוקי מים סטריליים מחוממים לטמפ' של 37° - 38° .
- החלפת אינקובאטור תתבצע אחת לשבועיים
- הרחצה באינקובאטור תתבצע באמצעות קערה סטרילית ופדים סטריליים
- הרחצה באינקובאטור תיעשה תוך הקפדה על חשיפת האזור הנרחץ בלבד, כששאר חלקי הגוף מכוסים בחיתול
- הרחצה תתבצע תוך הקפדה על תנוחה אסופה של הפג/ ילוד, לכל אורכה
- בתום הרחצה יש לייבש את הפג/ ילוד עם חיתול בד בעדינות, אין לשפשף, לאחר מכן, יש להעבירו לאזור יבש באינקובטור / בעריסה / הורים.
- בסיום הרחצה, האחות תנקה את הדפנות הפנימיות והחיצוניות של האינקובאטור ואת המזרון של הפג/ ילוד במגבון לניקוי סביבתי ותחליף את המצעים באינקובטור
- רחצת פג/ ילוד באינקובאטור פתוח, יש להקפיד על דפנות סגורות למעט הדופן בצד בו מטפלת האחות. כמו כן, בזמן החלפת המצעים יש להיעזר באיש צוות נוסף בהתאם למורכבותו של הפג/ ילוד.

רחצה באמבט:

- פגים/ ילודים יציבים ובריאים הנמצאים בעריסת חימום, עריסה רגילה או אינקובאטור משקלם מעל 1500 גרם וחום גופם לפני האמבט עולה על 36.7° ירחצו באמבט רחצה (מחוץ לאינקובאטור)
- התינוק יוכנס בהדרגתיות למים בתנוחה אסופה (מומלץ להיעזר בחיתול בד)
- הרחצה תתבצע תוך הקפדה על תנוחה אסופה של הפג/ ילוד לכל אורך זמן הרחצה
- בתום הרחצה, יוצא הפג/ ילוד בעדינות בעודו מכורבל, למשטח החתלה, כאשר מעליו מופעל חימום על מנת למנוע התקררות
- מיד לאחר הלבשת הפג/ ילוד וסיום הטיפול בו, יש לחברו למוניטור



- בסיום הרחצה, אמבט הרחצה יישטף במים וסבון על בסיס כלורקסידין ויעבור חיטוי עם היפוכלוריד על בסיס 500ppm
- יש לדאוג לסידור יחידת הפג/ ילוד וניקוי עריסתו. אין להחזיק את הפג/ ילוד ביד אחת וביד השנייה לנקות את העריסה או לחילופין להניחו על הדלפק בזמן ניקוי העריסה. יש להיעזר בעריסת שקילה.
- **רחצת פג/ ילוד עם צנתר מרכזי (PCCV) / PICC**
- רחצת פג/ ילוד עם צנתר מרכזי (PCCV) תעשה באינקובאטור סגור/ פתוח בלבד במיטת האשפוז, ולא באמבט
- אין להרטיב אזור צנתר פריפרי/ מרכזי במהלך רחצת הפג/ ילוד

רחצת פג/ ילוד הנמצא בבידוד (Isolation):

- רחצת פג/ ילוד הנמצא בבידוד עקב נשאות לחיידק עמיד, תתבצע רק באמבט אישי, בכיור ייעודי לבידוד תוך שמירה על כל כללי ההתנהגות בבידוד
- ניקוי יחידת הפג/ ילוד תכלול גם את ניקוי האינקובאטור או העריסה בהם הוא שוהה לרבות סביבתו עם מגבונים לניקוי סביבתי

רחצת פג/ילוד הזקוק לתמיכה נשימתית:

- תתבצע כאשר הפג/ילוד יציב בלבד
- תתבצע ע"י אחות ואיש צוות נוסף או הורה
- לאורך כל הפעולה יש לשמור על אספקת חמצן נאותה
- אין לנתק מקור חמצן בזמן הרחצה

טיפול ורחצת תינוק הסובל מ- ICHTHYOSIS:

- הקפדה על מריחת קרמים שומניים מאד, כדוגמת: AQUOSUM) HYDROUS OINTMENT (HADASSAH כל 3 שעות.
- יש למרוח על כל הגוף והפנים ללא יוצא מן הכלל.
- יש לרחוץ כל יום במים חמימים, ניתן לשים במים שמן חמניות. הרחצה עוזרת להוריד את העור הישן ומאפשרת התחדשות של העור. לאחר הרחצה, יש למרוח שוב במשחה שומנית

החלפת מצעים תתבצע לפי הצורך, ללא קשר לשקילה ורחצה

- בסיום השקילה והרחצה חובה לתעד את הפעולות בגיליון
- במידה והורי הפג/ ילוד הודרכו ו/ או ביצעו רחצה, יש לתעד זאת ברכיב ההדרכה
- חובה לציין אירועים חריגים בעת שקילה ו/ או רחצת הפג/ ילוד ואת פעולות הדיווח שננקטו



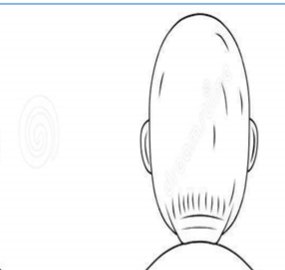
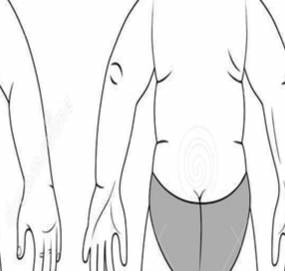
שבוע	תחילת רחצה	תכיפות רחצה	חומרי רחצה
עד 26	בגיל 10 ימים	1 בשבוע	מים מזוקקים מחוממים
27-30	בגיל 10 ימים	1 בשבוע	מים מזוקקים מחוממים
31-32	בגיל שבוע	2 בשבוע	מים מזוקקים מחוממים
33 ואילך	בשבוע הראשון	2 בשבוע	סבון לתינוקות
ילוד במועד	יממה ראשונה לאחר שחום גופו יציב למשך 2-4 שעות	2-3 פעמים בשבוע	מים וסבון לתינוקות

נספח 3: דף דיווח על פגיעה בעור

מדבקה

דיווח על פגיעה בעור

הערכה ראשונית - עד ששתיים מהקבלה. לאחר מכן, בתחילת כל משמרת ולפי הצורך
לסמן את מיקום הפגיעה ואת ציון חומרת הפצע בהתאם לסרגל אומדן פצע וסוג הפצע
במידה ויש פגיעות מרובות בעור, יש להתייחס לכל פגיעה בנפרד, לתת לכל פגיעה ציון
לדיווח על התערבות

מס' פצע	סוג הפצע		הניקוד של אומדן הפצע	תאריך ושעת גילוי הפצע	הטיפול שניתן
	כוויה / שפשוף / פצע לחץ / אודם / חתך ניתוחי וכו'				
שם האחות:					
מס' פצע	סוג הפצע		הניקוד של אומדן הפצע	תאריך ושעת גילוי הפצע	הטיפול שניתן
	כוויה / שפשוף / פצע לחץ / אודם / חתך ניתוחי וכו'				
שם האחות:					
מס' פצע	סוג הפצע		הניקוד של אומדן הפצע	תאריך ושעת גילוי הפצע	הטיפול שניתן
	כוויה / שפשוף / פצע לחץ / אודם / חתך ניתוחי וכו'				
שם האחות:					
שעה / תאריך					

מבטס על 4.18.18 Alberta skin assessment

נספח 4: הנחיות לטיפול בפגיעה בעור

הנחיות לטיפול בפגיעות עור				
הפגיעה	מניעה	טיפול בדרגת אודם קלה, ללא פגיעה בעור ו/או שלפוחיות	אודם משמעותי + שפשוף וקרעים קלים בעור	קרעים בעור ודימום
אדמומית בישבן	ואזלין / קרם שומני מבודד	CAVILON פעם ב-24 שעות או BABY PASTA או אינוטיל	פעם במשמרת קראסט העשוי משכבה אחת של CAVILON+ אבקת סטומה וביתר המשמרת - רק אבקת סטומה	השארת המקום באוויר הפתוח וטיפול עם קראסט פעם במשמרת וביתר הפעמים - אבקת סטומה בלבד
פצעים הנובעים משפשופים / סטייה של עירוי / כוויות מעירוים ושימוש בחומרים לא תקינים	מריחת CAVILON לפני הדבקת קיבועים / שונים / הדבקת פלסטרים	מריחת CAVILON פעם ב-72 שעות	הנחת יריעת דבש / רשת דבש והחלפה כל 72 שעות	הנחת יריעת דבש / רשת דבש והחלפה כל 72 שעות
פצעי ניתוח / פצעים מזוהמים / פצעים מפרישים	מריחת CAVILON כל 72 שעות	מריחת CAVILON פעם ב-72 שעות	הנחת יריעת דבש / רשת דבש והחלפה כל 72 שעות	הנחת יריעת דבש / רשת דבש והחלפה כל 72 שעות, במידה והפצע עמוק ומפריש - הזלפת דבש רפואי נוזלי כמו: REVAMIL / L- MESITRAN לתוך פנים הפצע
סטומה מפרישה	קראסט מ-2 שכבות לסרוגין של CAVILON ואבקת סטומה	קראסט מ-2 שכבות לסרוגין של CAVILON ואבקת סטומה	קראסט מ-3 שכבות לסרוגין של CAVILON ואבקת סטומה	קראסט מ-3 שכבות לסרוגין של CAVILON ואבקת סטומה



נספח 5: סרגל Q BRANDEN

הבסיס לאומדן הוא סרגל: (NSARS (infants 0 to 20 days) הבסיס הנוסף לתינוקות מעל גיל 20 יום: BRADEN Q

NEONATAL SKIN RISK ASSESSMENT SCALE (NSRAS)

General Physical Condition	4. Gestational age < 28 weeks	3. Gestational age > 28 weeks but < 33 weeks	2. Gestational age > 33 weeks but < 38 weeks	1. Gestational age > 38 weeks to postterm	Score
Mental Status	4. Completely limited Unresponsive (does not flinch, grasp, moan, increase blood pressure, or heart rate) to painful stimuli due to diminished level of consciousness or sedation.	3. Very limited Responds only to painful stimuli (flinches, grasps, moans, increased blood pressure or heart rate).	2. Slightly limited Lethargic.	1. No impairment Alert and active.	
Mobility	4. Completely immobile Does not make even slight changes in body or extremity position without assistance (e.g., Pavulon).	3. Very limited Makes occasional slight changes in body or extremity but unable to make frequent changes independently.	2. Slightly limited Makes frequent though slight changes in body or extremity position independently.	1. No limitations Makes major and frequent changes in position without assistance (e.g., turn head).	
Activity	4. Completely bed-bound In a radiant warmer with a clear plastic "saran" tent.	3. Limited bed bound In a radiant warmer without a clear plastic "saran" tent.	2. Slightly limited In a double walled isolette.	1. Unlimited In an open crib.	
Nutrition	4. Very poor NPO on intravenous fluids.	3. Inadequate Receives less than optimum amount of liquid diet for growth (formula/ breast milk) and supplemented with intravenous fluids.	2. Adequate Is on tube feedings which meet nutritional needs for growth.	1. Excellent Bottle/breastfeeds every meal which meets nutritional needs for growth.	
Moisture	4. Constantly moist Skin is moist/damp every time infant is moved or turned.	3. Moist Skin is often but not always moist/damp; linen must be changed at least once a shift.	2. Occasionally moist Skin is occasionally moist/damp. Requiring an extra linen change approximately once a day.	1. Rarely moist Skin is usually dry, linen requires changing only every 24 hours.	

If score ≥ 13 begin infant on Standard of Care of Neonate at risk for skin injury.

Used with permission from "The Neonatal Skin Risk Assessment Scale for Predicting Skin Breakdown in Neonates" Issues in Comprehensive Pediatric Nursing Volume 20 Issue 2, 1997